

1

Obstipation

CE 02/ UE 04 Ausscheiden



Definition

- Symptom
- Weniger als 3 Ausscheidungen pro Woche
- Führt zu Unwohlsein, Schmerzen, Druck- und Völlegefühl, Blähungen, Appetitlosigkeit
- Verschiedene Ursachen möglich:
 - funktionelle
 - habituelle

Ursachen

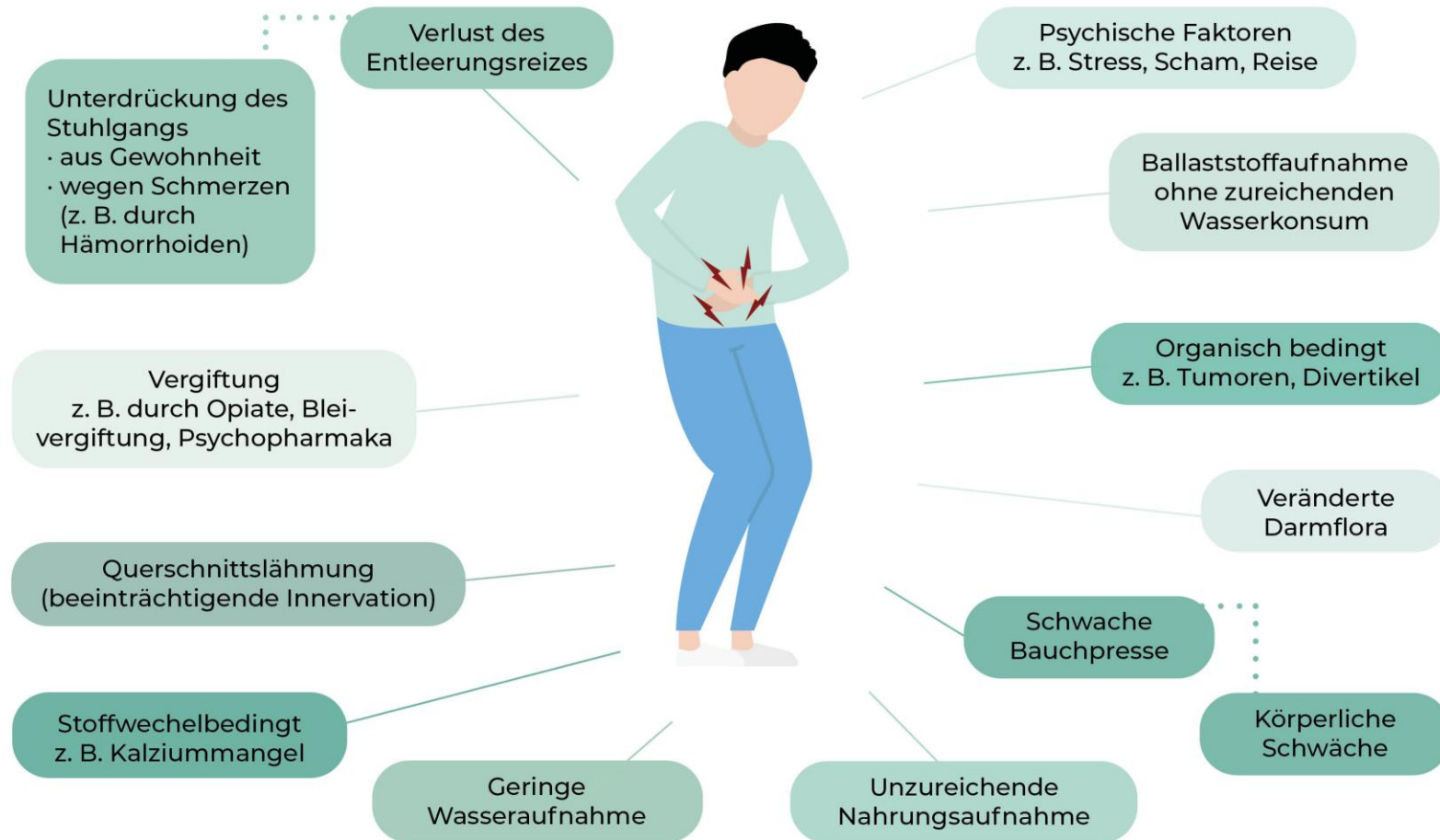
➤ Funktionell

- Stenosen
- Tumore
- hormonelle Störung (z.B. Hypothyreose)
- Nebenwirkungen von Medikamenten (z.B. BTM)
- Lähmungen des Darms

➤ Habituell

- betrifft den Lebensstil, z.B. Stress, Bewegungsmangel, Adipositas, verminderte Nahrungsaufnahme, niedriger Flüssigkeitshaushalt, ungewohnte Umgebung

Ursachen einer Obstipation



Warum ist es wichtig, dies frühzeitig zu erkennen?

Komplikationen:

- Megakolon (= aufgetriebener, aufgedehnter Dickdarm) ⇒ durch Ansammlung großer Mengen Stuhl im Dickdarm
- Vermehrter Harndrang bis hin zur Harninkontinenz (v. a. bei übergewichtigen Frauen)
- Hämorrhoiden ⇒ durch hohe Kraftaufwendung der Bauchpresse beim Stuhlgang
- Paralytischer Ileus (= Lähmung der Darmmuskulatur)
- Mechanischer Ileus (= mechanischer Darmverschluss)
- Chronische Kolitis (= chronische Entzündung des Dickdarms) ⇒ durch Missbrauch von Abführmitteln oder regelmäßigen Darmeinläufen

Obstipationsprophylaxe



Thema 1: Ernährung und Trinken

- Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten
- Ballaststoffreiche Ernährung (ca. 35-40 g/Tag z. B. durch Obst, Gemüse, Vollkornprodukte)
- (Sauer)Milchprodukte anbieten $\Rightarrow$ Milchsäurebakterien verbessern die Darmflora (z. B. Joghurt)
- Sauerkraut, Spinat- oder Kohlgerichte $\Rightarrow$ zellulosereiche Kost hat einen ähnlichen Effekt wie Milchprodukte
- Stopfende Nahrung vermeiden (z. B. Weißbrot, Bananen, Schokolade)
- Beim Essen gut kauen und Zeit lassen
- Produkte anbieten, welche die Verdauung beschleunigen (z. B. eingelegte Trockenpflaumen oder Laktose)

Obstipationsprophylaxe



Thema 2: Bewegung

- Frühmobilisation
- Regelmäßiger Wechsel zwischen Aufstehen, Sitzen, Liegen und Laufen
- Motivieren Sie die Pflegeempfänger/innen
- Einbezug der zu pflegenden Personen in Pflegemaßnahmen
- Bewegungsübungen zeigen, die die Pflegeempfänger/innen selbst zwischendurch durchführen können (z. B. Mit Armen nach oben greifen, "Fahrrad fahren" im Bett)
- Ressourcen und Hilfsmittel der Pflegeempfänger/innen nutzen
- Hilfsmittel für aktive Bewegungsübungen (z. B. Bettfahrrad)

Obstipationsprophylaxe

Thema 3: ungewohnte Umgebung

- Intimsphäre der Pflegempfänger/innen wahren
- Stuhlgang in einem geschützten Raum ermöglichen
- Mitpatient/innen nach Möglichkeit so lange aus dem Zimmer bitten
- Angehörige und Besuch so lange aus dem Zimmer bitten
- Nach Möglichkeit die zu pflegende Person während dem Toilettengang alleine lassen
- Defäkationsrituale erfragen und ermöglichen (z. B. Kaffee am Morgen, Zeit nach dem Frühstück ermöglichen)
- Pflegeempfänger/in durch Ihre Haltung und im Gespräch das Schamgefühl nehmen und Ihre Unterstützung anbieten

Haltung ohne Hocker



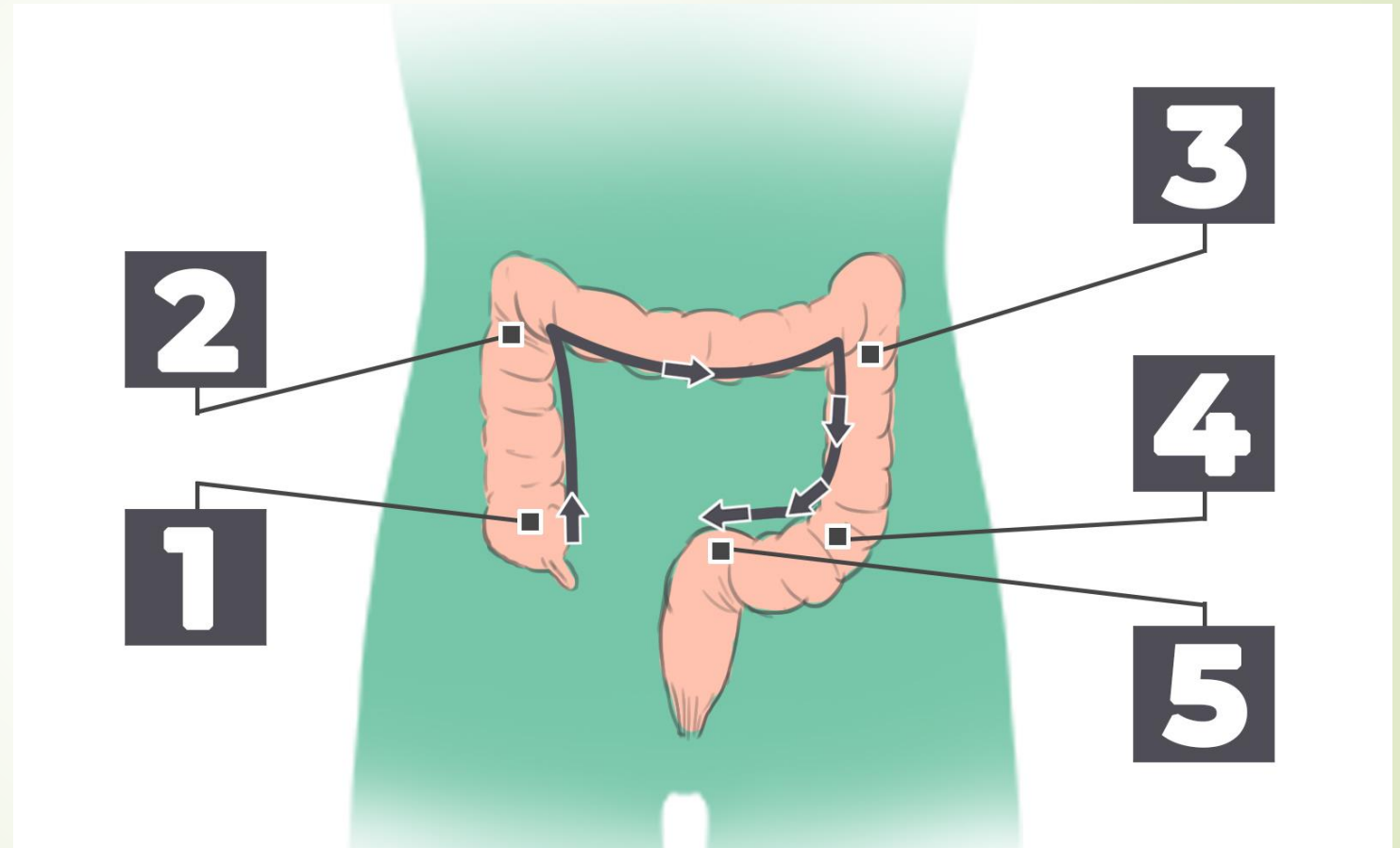
Haltung mit Hocker



Kolonmassage nach Vogler

= Anregung der
Darmperistaltik mit
angenehmem Druck

= fünf Minuten am Besten am
Morgen - entlang des
Dickdarms



Einsatz von Laxanzien

= Mittel, die die Darmentleerung fördern

- **Quellstoffe:** das Quellen von Ballaststoffen im Darm (z.B. Flohsamenschalen)
- **Schleimhautreizende Mittel:** Irritation der Schleimhaut zur Steigerung der Peristaltik (z.B. Laxoberal)
- **Osmotische Mittel:** die osmotische Wasseranziehung in den Darm (z.B. Macrogol)
- **Gleitmittel:** das Aufweichen und gleitfähiger machen des Stuhls (z.B. Paraffin)

AA Gruppenarbeit

- Erstellung One-Minute-Wonder (OMW) auf einem Plakat/ einer digitalen Seite → Die wichtigsten Informationen abbilden, gerne auch mit Bildern/ Abbildungen (dazu ILIAS: „Bilder zu Laxanzien“).
- Digital → z.B. Nutzung „OMW_Vorlage“
- Nutzung Nova-Heal (Kapitelname: Abführmittel (Laxanzien))
- Zusendung (wenn digital) an marie.renerken@cbg-aachen.de

Beispiele One-Minute Wonder in der Pflege

ONE-MINUTE-WONDER Eine Minute Wissen-Kompakt

Das EKG

Teil II

Was ist ein Elektrokardiogramm, kurz EKG?

eine temporäre oder dauerhafte Aufzeichnung der Summe der elektrischen Aktivitäten von Herzmuskelfasern

EKG-Arten?

- Ruhe EKG
- Langzeit EKG
- Belastung EKG



„Ampel-System“

Erhebungen im EKG?

- P-Welle:

Sie entsteht durch die Ausbreitung der Erregung in den Vorhöfen des Herzens.

- QRS-Komplex:

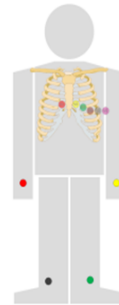
Ein scharf gezackter Komplex, der der Depolarisation beider Kammern entspricht.

- T-Welle:

Sie entsteht durch die Erregungsrückbildung der Herzkammern.

- U-Welle:

Eine inkonstant auftretende Erhebung nach der T-Welle.



Quelle: Bild:
<https://pintobrasil-group.com/ekg-anlegen-nach-farben-k.html/>
<https://media.springernature.com/lw387/springer-cms/rest/v1/content/16085486/data/v2?aa=jpg>

KLINIKUM
WILHELMS
HAVEN

Was ist ein Delir?

Aufmerksam sein

Ein Delir ist eine akute organische Störung im Gehirn. Sie führt zu Verwirrtheit und einer gestörten Wahrnehmung. Ein Delir stellt ein hohes Gesundheitsrisiko für ältere pflegebedürftige Menschen dar.



VERLAUF

- plötzlicher Beginn
- über Stunden, Tage oder Wochen anhaltend
- schwankender Verlauf, ggf. Symptom-Verstärkung am Abend
- teilweise wechselnde Symptome

SYMPTOME

Kognition/Psyche

- Orientierungsstörung
- Gedächtnisprobleme
- Wahn/Halluzination
- Störung von Stimmung und Emotion, z. B. Aggression, Angst

Aktivität/Psychomotorik

- Hyperaktivität, z. B. Unruhe, Nesteln
- Hypoaktivität, z. B. Antriebslosigkeit, Benommenheit
- Wechsel von Hyper-/Hypoaktivität

Schlaf-Wach-Rhythmus

- nächtliche Aktivität
- Schläfrigkeit am Tag

Delir-Symptome sind vielgestaltig und teils unauffällig. Deshalb wichtig: **Genau hinschauen.**

RISIKEN

Ein Delir kann sich vollständig zurückbilden. Aber es kann auch schwerwiegende und langfristige Folgen haben:

- psychische Belastung
- geistige Beeinträchtigung
- Komplikationen, z. B. Infektion, Sturz
- erhöhter Pflegebedarf (früherer) Tod

© Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP)
August 2024
Illustration: Marion Ansel

One-Minute-Wonder zu Delir-Prävention in der Pflege:
weitere Informationen und Materialien zur Delir-Prävention und -Linderung sind frei zugänglich: www.zqp.de



Anwendung Zäpfchen/ Suppositorium

- Nicht aus der Verpackung drücken, nur vorsichtig Folie abziehen
- In linker Seitenlage, mit leicht angewinkelten Beinen
- Mit der stumpfen Seite voran einführen (gleitet nicht so schnell wieder heraus)
- Keine Salben/ Cremes zusätzlich nutzen



Weitere Abführmaßnahmen

Klistier/ Klysma:

= Einbringen Flüssigkeitsmenge rektal 5-300ml

- Mechanischer Reiz = Dehnung Darmwand durch Flüssigkeit
- Thermischer Reiz = körperwarme Lösung
- Chemisch-osmotischer Reiz = verstärkte Sekretion der Darmschleimhaut

KONTRAINDIKATION bei: Blutungen, Darmverletzungen, Peritonitis (Bauchfellentzündung), mechanischer Ileus

- Niemals gegen Widerstand weiterschieben
- Kann zu Kreislaufbelastung führen (VZ-Kontrolle!!)

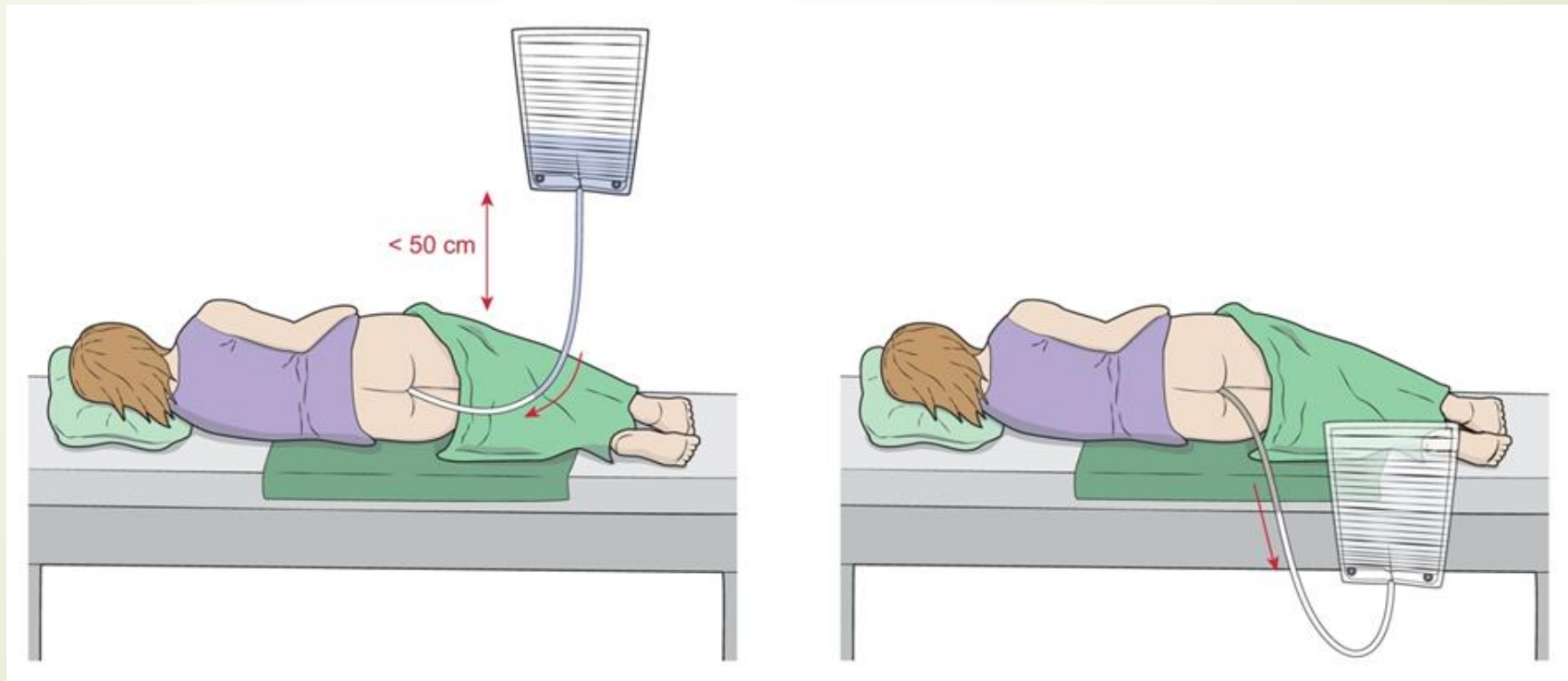


Verabreichung Klistier/ Klyσμα

- Information über den Ablauf
- Handschuhe, Klistier (eventuell mit Vaseline einfetten), Unterlage
- Ggf. Toilettenstuhl in Nähe bringen / freie Toilette gewährleisten
- Schutzkappe abnehmen
- Pflegeempfänger/in auffordern einzuatmen, dabei Darmrohr vorsichtig langsam in den Darm einführen
- Klyσμα ausdrücken und aufrollen
- Pflegeempfänger/in auffordern Schließmuskel anzuspannen
- Klyσμα entfernen und Pflegeempfänger/in bitten, mit der Stuhlentleerung ca. 5-15 Minuten zu warten

Weitere Abführmaßnahmen

Schwenkeinlauf/ Hebe-Senk-Einlauf:



Vorbereitung Schwenkeinlauf

- Zusammensetzung je nach Standard
z.B. 2 Klysma (= 260ml) + 1740ml Wasser lauwarm
- Entlüftung Schlauchsystem!
- Handschuhe zum Eigenschutz
- Vitalzeichenkontrolle
- Positionierung in Linksseitenlage mit angezogenen Beinen
- Wasserdichte Unterlage unter das Gesäß



Schwenkeinlauf/ Hebe-Senk-Einlauf

- Darmrohr mit Vaseline einfetten
- Darmrohr vorsichtig mit drehender Bewegung 10-20cm einführen
- Irrigator anheben bis max. 50cm, Klemme öffnen, Spülflüssigkeit läuft ein
- Beobachtung Beschwerden (Schmerzen, Kreislaufbelastung o.ä.)
- Sobald Flüssigkeit eingelaufen ist, Irrigator unter Körperriveau (nach unten) halten
- Wiederholung Prozess (bis Flüssigkeit bräunlich getrübt ist)
- Vitalzeichenkontrolle, Dokumentation, Beschwerden erfragen